

Información Paciente

Nombre : Sergio Armando Polanco Elgueda
Edad : 61a 3m 2d
Dirección : Pje 5

Rut : 9.805.126-0
Fecha Nacto: 14/05/1964
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2209485
Sexo : Masculino
Teléfono : 932040160

N° Epicrisis
451800

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji
Unidad de Egreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji

Fecha Ingreso : 11/08/2025 07:05
Fecha Egreso : 16/08/2025 09:08

Días Estadía: 5

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Ileostomia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Edad: 60
Dg: Ileostomia

AM: No
AQ: laparotomia e ileostomia terminal en mayo 2022
Fcos: risperidona, quetiapina, pregabalina, paracetamol
Alergias: No

MC: En mayo 2022 debuta con peritonitis fecaloidea de 4 cuadrantes por perforación de ileon distal de causa no precisada. En ese momento se realiza colecistectomia, reseccion de 20 cm de intestino delgado e ileostomia.

Colonoscopia 22/12/22: incompleta, rectosigmoidoscopia.

TC TAP 18/06/22:

Disminución del hidroneumotórax derecho actualmente de leve a moderada cuantía.

Resolución de los signos de bronquiolitis en el LII y disminución de tamaño de pequeño foco cavitado en el LSI.

Disminución de la ascitis, actualmente laminar a nivel perihepático derecho.

Resto del estudio sin cambios significativos.

CEA -

Exs lab

30/07/25: INR 1.17, TTPA 32.4 , Alb 30, Creat 1.01 Prealb 15.6; Glicemia 94 , hb 11.1 GB 8.4, plaq 423, elp 140/5.18/113

PLAN: Reconstitución de transito (abierta)

Evolución coloproctologia

Se realiza aanastomosis enteroenteral tipo barcelona abierta

Evoluciona favorablemente

Bien, afebril
HDN estable,

Fecha Epicrisis : 16/08/2025 09:05

Fecha Última Actualización: 16-08-2025 9:05:42

Página 2 de 3

Dolor leve, tolerable,
sin nauseas ni vomitos
transito a gases; depos sin sangre +
diu ++ cc
buena tolerancia a regimen papilla

abdomen blando
herida ok

lab 13/08 pcr 58 gb 11.8 creat 1.19 hb 10
16/08/25: pcr 78 , hb 10.5 gb 9

plan
alta

Diagnóstico de Egreso

ILEOSTOMIA -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Buenas condiciones
buena tolerancia oral
sin dolor
con transito a gases

Plan Post Alta

- Reposo relativo en domicilio. Mantenerse activo a tolerancia evitando reposo prolongado en cama.
- Régimen según pauta: Papilla (Todo molido por licuadora por 2 semanas).
- Hidratación con abundante agua (al menos 1 litro al día)
- Fármacos:
 - * Paracetamol 500 mg: 2 comprimidos cada 8 horas vía oral x 5-7 días
 - * Metamizol 300 mg cada 8 horas via oral x 5 días
 - * Omeprazol 20 mg en la mañana vía oral x 5 días
 - * En caso de constipación, utilizar PEG (polietilenglicol 3350) 1 sobre 17 grs al día vía oral en 250 cc de agua
 - * Mantener toma de medicamentos habituales
- Control en DIPRECC en 2-3 semanas. se le contactará para coordinar hora de control.
- Acudir a consultorio el lunes para curaciones de ileostomia, en caso de necesidad; o en pasillo 11 CDT hospital soterio del rio.
- Acudir a Servicio de Urgencias en caso de fiebre (temperatura axilar mayor o igual a 38°C), dolor abdominal intenso que no cede con analgesia, vómitos a repetición, sangrado importante, enrojecimiento o salida de pus por heridas o según necesidad

Indicaciones

Tipo de Reposo : Levantar A Sillon

Régimen Alimentario : Papilla

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 16/08/2025 09:05

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 16-08-2025 9:05:42

Página 3 de 3

Bec. Javier Vela Ulloa

Becado/Residente

INTERNO

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 16/08/2025 09:05

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:16

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar